

QUEIMADURAS

Queimaduras: Avaliação e Conduta

- Queimaduras são **lesões dinâmicas** e sua evolução pode agravar-se.
- A reavaliação constante é crucial devido a sinais tardios.

Classificação por Profundidade

1º Grau (Superficial)

Acomete apenas a epiderme. Eritema, dor, sem bolhas. Cicatriza espontaneamente.

2º Grau (Espessa)

Afeta epiderme e derme. Bolhas (podem aparecer tardiamente), dor intensa, inchaço. Pode deixar cicatrizes.

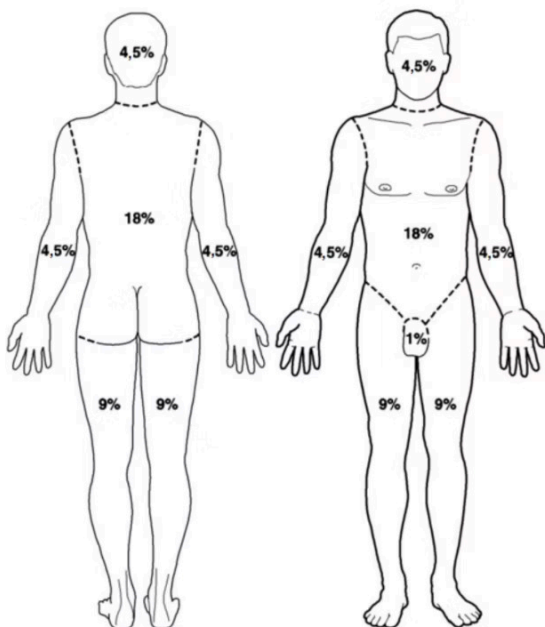
3º Grau (Total)

Destroi todas as camadas da pele e tecidos profundos. Indolor, pele esbranquiçada/carbonizada. Requer enxerto.

Classificação por Extensão

Métodos de Estimativa da Superfície Corporal Queimada (SCQ):

- **Regra dos Nove (Adultos):** Utilizada para estimar a porcentagem da superfície corporal queimada.



Leve

Adultos: <10% SCQ



Moderada

Adultos: 10-20% SCQ



Grave

>20% SCQ ou qualquer 3º grau

Atenção: Áreas Nobres e Localizações Críticas



Face e Olhos

- Risco de comprometimento de vias aéreas e lesão ocular.



Mãos, Pés e Genitália

- Áreas críticas com alto risco de infecção e sequelas.



Suspeita de Inalação

- Complicação letal; sinais incluem queimaduras faciais e rouquidão.

Avaliação e Fatores de Gravidade de Queimaduras

Fatores de Gravidade

- **Idade Extrema:** Crianças < 2 anos e adultos > 60 anos.
- **Extensão:** 2º grau > 10% SCQ, ou 3º grau > 5% SCQ.
- **Áreas Nobres:** Face, mãos, pés, genitália, períneo ou grandes articulações.
- **Queimaduras Elétricas/Químicas.**
- **Doenças Preexistentes.**
- **Lesão por Inalação.**
- **Trauma Concomitante.**

Orientações e Fluxo de Atendimento para Queimaduras

Cuidados Domiciliares Essenciais

- Limpeza diária suave e troca de curativos.
- Manter a área elevada e **NÃO** romper bolhas.
- Retornar em caso de sinais de alerta ou reavaliação em 24-48h (2º grau).

Internação e Avaliação da Cirurgia

- **Queimaduras de 3º grau:** Indicam destruição completa da pele, exigindo internação e avaliação cirúrgica.
- **Acometimento de Áreas Nobres:** Queimaduras em face, mãos, pés, genitália/períneo ou grandes articulações.
- **Extensão $\geq 10\%$ SCQ (2º grau) ou $> 5\%$ SCQ (3º grau).**
- **Piora Clínica:** Dor/edema progressivo, febre, secreção purulenta ou bolhas grandes/dolorosas.
- **Queimaduras Elétricas/Químicas:** Potencial para lesões internas graves.
- **Lesão por Inalação:** Complicação letal, exige internação.

Manejo Inicial: Primeiras 24 Horas (SBQ 2026)

⚠ Conforme Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) – Atualização 2025 Priorize ABCDE + ressuscitação volêmica. Fonte: Protocolo SBQ + ACLS adaptado.

Avaliação Inicial (ABCDE – Primeiros 10 min)

A (Vias Aéreas)	Intubação se inalação de fumaça ou edema laríngeo.
B (Respiração)	O2 100% se hipoxemia ou CO >10%.
C (Circulação)	Acesso venoso calibroso (2x14G). Monitorar urina (meta: 0,5-1 mL/kg/h adultos; 1-2 mL/kg/h crianças).
D (Deficiência Neurológica)	Analgesia (morfina 0,05-0,1 mg/kg EV).
E (Exposição)	Remover roupas, cobrir com lençol estéril.

Ressuscitação Volêmica (Fórmula de Parkland) ATLS 2011

Categoria de Queimadura	Idade e Peso	Ajustado por hora Taxa de Fluido (ml/h)	Urina Saída Meta
Térmica ou Químico Queimar	Adultos e Idosos	$2 \text{ ml LR} \times \text{kg} \times \% \text{ TBSA}$	0,5 ml/kg/h
	Crianças ≥13 anos de idade	16	(30–50 ml/horas)
	Crianças <13 anos	$3 \text{ ml LR} \times \text{kg} \times \% \text{ TBSA}$ 16	1 ml/kg/h
Elétrica	Bebês e crianças pequenas <30 kg	$3 \text{ ml LR} \times \text{kg} \times \% \text{ TBSA}$ 16 Mais D5LR com taxa de manutenção	1 ml/kg/h
	Todas as idades	$4 \text{ ml LR} \times \text{kg} \times \% \text{ TBSA}$ 16 Crianças <13 anos requerem D5LR na taxa de manutenção	1–1,5 ml/kg/h até que a urina esteja livre de pigmentos
0,5 Ferida			

A hidratação pode variar em relação aos valores previamente protocolados, caso a diurese não se apresente dentro do padrão descrito na tabela acima.

🚑 **CRITÉRIO DE TRANSFERÊNCIA:** Encaminhar para Centro Especializado em Queimados se SCQ >10% ou acometimento de áreas nobres.

SEGURANÇA DO PACIENTE

Cuidados Locais (Não perfurar bolhas!)

Limpeza	SF 0,9% ou clorexidina 0,12%. Sem sabão.
Curativo	Sulfadiazina de prata 1% (se 2º/3º grau >10% SCQ) OU hidrofibra com prata. Troca a cada 24-48h.
Desbridamento	Cirúrgico precoce se 3º grau ou necrose.
Antibióticos	Profilaxia só se infecção confirmada (cultura). Evitar rotina.
Analgesia	Paracetamol + opioides EV.

Monitoramento (UTI se >20% SCQ)

- Sinais vitais/hora.
- Eletrólitos, Hb, gasometria.
- Nutrição enteral precoce (<24h).
- Tétano: Profilaxia se não vacinado.

 **CRITÉRIO DE TRANSFERÊNCIA:** Encaminhar para Centro Especializado em Queimados se SCQ >10% ou acometimento de áreas nobres.

Mensagem Final: Princípios da Boa Prática

Nunca Subestimar

Queimaduras são dinâmicas e imprevisíveis.

Tempo é Tecido

Ação cirúrgica precoce salva tecido e função.

Boa Prática Essencial

Documentação completa, orientação clara e acionamento especializado.

Referências: Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ). Protocolo de Tratamento de Queimaduras Agudas – Atualização 2025. Ministério da Saúde (MS). Diretrizes Nacionais de Assistência às Vítimas de Queimaduras. Brasília: MS; 2024.